CUESTIONARIO NEUROLOGIA 1 2024	
1.Un paciente consulta en el servicio de urgencia por cefalea de localización parietooccipital, muy intensa, que inició hace una hora y es de carácter opresivo. El dolor inició súbitamente y mantiene una intensidad constante. El diagnóstico de sospecha es:	a.Neuralgia de Arnold b.Jaqueca c.Cefalea tensional d.Embolia cerebral e.Hemorragia subaracnoidea
2. Un paciente presenta cervicobraquialgia, luego de trabajar limpiando una acequia. El dolor se irradia a la extremidad superior derecha, por la cara posterior del brazo y antebrazo, hasta los dedos índice y medio. Además, presenta disminución del reflejo tricipital ipsilateral. La raíz afectada es:	a.C5 b.C6 c.C7 d.C8 e.T1
3. Una paciente de 23 años presenta una neuritis óptica, que es manejada con corticoides, con buena evolución. Dos meses después presenta un cuadro de hemiparesia derecha, que se instala en 2 días. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome de Guillain Barré b.Esclerosis múltiple c.Accidente vascular encefálico d.Tumor cerebral e.Miastenia gravis
4. Un paciente sufre un traumatismo encefalocraneano y evoluciona con visión doble. Al examen físico se aprecia estrabismo convergente, e imposibilidad de mirar a la derecha con el ojo derecho. El diagnóstico más probable es:	a.Lesión de III nervio cranea (oculomotor) b.Lesión de IV nervio cranea (troclear) c.Lesión de VI nervio cranea (abducens) d.Lesión del fascículo longitudinal medial e.Síndrome de Horner
5. Un paciente de 17 años presenta un cuadro de debilidad generalizada, asociada a parálisis facial bilateral, que se ha instaurado en pocos días. Probablemente presentará, además:	a.Miosis b.Midriasis c.Afasia d.Abolición de los reflejos osteotendíneos e.Espasticidad
6. Una polineuropatía suele presentar todos los síntomas y signos mencionados a continuación, EXCEPTO:	a.Hipoestesia b.Hiporreflexia c.Debilidad de predominio proximal d.Fasciculaciones e.Atrofia muscular
7. ¿Cuál es el diagnóstico más probable frente a un paciente que presenta súbitamente imposibilidad para evocar palabras y hemiparesia derecha?	a.Accidente vascular encefálico b.Hemorragia subaracnoidea c.Epilepsia focal d.Crisis miasténica e.Meningitis herpética
8. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de horas de agitación y desorientación temporoespacial. Al examen físico está muy asustado, diciendo que lo quieren matar. Sus familiares están muy preocupados. El tratamiento farmacológico más adecuado para este paciente es:	a.Levodopa b.Donepezilo c.Risperidona d.Propanolol e.Sintomático
9. Identifique la asociación incorrecta entre el microorganismo causante de meningitis y el tratamiento antibiótico de elección:	a.Streptococcus pneumoniae – Ceftriaxona b.Neisseria meningitides – Ceftriaxona c.Listeria monocytogenes – Ampicilina d.Haemophilus influenzae – Ampicilina e.Escherichia coli – Ceftriaxona
10. Un niño de 10 años presenta una convulsión tónico-clónica, por los que sus padres llaman a la ambulancia. Usted lo recibe en el servicio de urgencia 15 minutos después de haber iniciado la crisis y continúa convulsionando en la fase clónica. La conducta más adecuada es:	a.Administrar oxígeno, instalar una vía venosa periférica y mantener una conducta expectante b.Solicitar un electroencefalograma de urgencia c.Administrar lorazepam endovenoso d.Realizar una punción lumbar de urgencia e.Administrar diazepam intramuscular
11. La hemisección medular a nivel torácico se caracteriza por:	a.Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral b.Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral c.Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral d.Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y

Lia...

	ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral e.Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral
12. ¿Cuál de los siguientes síntomas es frecuente en la enfermedad de Parkinson?	a.Mioclonías y mioquimias b.Demencia, presente desde el inicio del cuadro c.Nistagmo d.Retrocollis (distonía con extensión cervical) e.Disminución de movimientos de los brazos, durante la marcha
13. Un paciente de 45 años presenta debilidad de la pierna izquierda y la mano izquierda. Al examen físico se aprecia aumento del tono muscular, con hiperrreflexia y paresia moderada de ambas extremidades, sin atrofia. Se constata que el reflejo plantar izquierdo es extensor. El diagnóstico más probable es:	a.Esclerosis lateral amiotrófica b.Síndrome cerebeloso, con compromiso del hemisferio cerebeloso izquierdo c.Siringomielia d.Síndrome piramidal e.Polineuropatía, con denervación muscular
14. Un paciente presenta cefalea de predominio matinal, asociado a náuseas y vómitos ocasionales. Se solicita un fondo de ojo que muestra edema de papila bilateral. No presenta signos focales y la resonancia magnética nuclear es normal. El diagnóstico más probable es:	a.Cefalea Cluster b.Síndrome de hipertensión endocraneana c.Tumor cerebral d.Hidrocefalia e.Migraña
15. Paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, presenta dificultades para mover el hemicuerpo izquierdo. Al examen neurológico, tiene una hemiparesia facio-braquio-crural izquierda, moderada, sin alteraciones en la sensibilidad. Al tercer día se ha recuperado casi por completo. El diagnóstico más probable es:	a.Infarto lacunar b.Crisis isquémica transitoria c.Migraña hemipléjica d.Accidente vascular embólico e.Infarto aterotrombótico de circulación anterior
16. Un paciente sufre una lesión en la cintilla óptica derecha. ¿Qué alteración esperaría encontrar en la campimetría?	a.Hemianopsia bitemporal b.Hemianopsia homónima derecha c.Hemianopsia homónima izquierda d.Amaurosis derecha e.Amaurosis izquierda
17. Un paciente presenta marcha inestable, con aumento de la superficie de sustentación, asociada a dismetría e imposibilidad de realizar movimientos alternantes. ¿Qué patología es más concordante con el cuadro descrito?	a.Accidente vascular encefálico lacunar b.Hemorragia cerebelosa c.Accidente vascular talámico d.Síndrome piramidal e.Síndrome extrapiramidal
18. Una mujer de 68 años presenta un cuadro de 12 meses de evolución de problemas de memoria, ideas paranoides y alucinaciones visuales. Presenta además caídas frecuentes y temblor de la mano izquierda. Los síntomas son fluctuantes, pero muestran una tendencia a empeorar. El diagnóstico más probable es:	a.Demencia por cuerpos de Lewy b.Enfermedad de Alzheimer c.Delirium d.Demencia frontotemporal e.Hidrocefalia normotensiva
19. Existen numerosos medicamentos que sirven para prevenir la ocurrencia de ataques de migraña. Uno de estos medicamentos es:	a.Indometacina b.Propanolol c.Ergotamina d.Verapamilo e.Tramadol
20. ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele presentarse en la parálisis facial periférica idiopática?	b.Imposibilidad de levantar la ceja c.Hiperacusia d.Disgeusia e.Desviación de la comisura labial

CUESTIONARIO NEUROLOGIA 2 2024	
1.Un paciente presenta de manera súbita una hemianopsia homónima derecha. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar una punción lumbar b.Realizar fondo de ojo c.Solicitar TAC de cerebro de urgencia d.Iniciar anticoagulación con heparina e.Iniciar corticoides orales
2. Un paciente presenta debilidad de las 4 extremidades, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. La debilidad es de predominio proximal y al examen físico se aprecia hipertrofia de las masas musculares. El diagnóstico más probable es:	a.Polineuropatía b.Síndrome piramidal c.Síndrome de Guillain Barré d.Miastenia gravis e.Miopatía
3. Un paciente de 67 años consulta por temblor de la mano izquierda. Al examen se aprecia marcha insegura, con disminución del braceo y temblor de reposo, que desaparece al tomar un objeto. El tratamiento de la patología descrita es:	a.Corticoides orales b.Antagonistas beta-adrenérgicos c.Agonistas beta-adrenérgicos d.Antagonistas dopaminérgicos e.Agonistas dopaminérgicos
4. Un paciente sufre una parálisis facial periférica. ¿Qué alteración es MENOS compatible con este diagnóstico y obliga a sospechar una causa central?	a.Lagoftalmo b.Disgeusia c.Disminución de la sensibilidad del trago d.Debilidad de los músculos masticatorios e.Hiperacusia
5. Un paciente presenta disminución progresiva de la sensibilidad termalgésica en las extremidades superiores, conservando la sensibilidad táctil y la sensibilidad de las extremidades inferiores, tanto táctil, como termalgésica. El diagnóstico de sospecha es:	a.Síndrome de Brown Sequard b.Síndrome de cauda equina c.Síndrome de arteria espinal anterio d.Síndrome de arteria espinal posterior e.Siringomielia
6. Un paciente presenta hemiparesia derecha, asociada a parálisis facial izquierda. La lesión se encuentra en:	a.La corteza motora b.La médula espinal c.El cerebelo d.Los núcleos de la base e.El puente o protuberancia
7. Las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, se caracterizan por:	a.Afectación motora b.Afectación sensitiva c.Afectación de la atención d.Afectación de la memoria e.Afectación cuantitativa de la conciencia
8.Un paciente presenta un cuadro de parálisis progresiva, con abolición de los reflejos osteotendíneos. Además, se constata disminución del tono muscular. El diagnóstico más probable es:	a.Polineuropatía b.Esclerosis lateral amiotrófica c.Esclerosis múltiple d.Síndrome de Guillain Barré e.Miastenia gravis
9. La asociación de midriasis, ptosis y estrabismo es característica de:	a.Síndrome de Horner b.Parálisis del tercer nervio craneal c.Lesión del fascículo longitudinal medial d.Infarto de protuberancia anular e.Miastenia gravis
10. El análisis de líquido cefalorraquídeo, en un paciente con meningitis viral, se caracteriza por:	a.Pleocitosis de tipo mononuclear, con glucorraquia normal b.Pleocitosis de tipo mononuclear, con glucorraquia disminuida c.Elevación de las proteínas, sin pleocitosis d.Pleocitosis, sin elevación de las proteínas e.Bandas oligoclonales de inmunoglobulinas
11. Un paciente de 74 años presenta agitación psicomotora de 48 horas de evolución, asociado a la idea de que fantasmas quieren matarlo. Al examen neurológico no presenta focalidad, aunque no sabe qué año es, ni dónde está. El diagnóstico más probable es:	a.Demencia por cuerpos de Lewy b.Hidrocefalia normotensiva c.Accidente vascular encefálico d.Demencia frontotemporal e.Síndrome confusional agudo
12. Un niño de 6 años presenta una convulsión tónico-clónica, de 2 minutos de duración, autolimitada. No había presentado síntomas previos. Al examen físico está en buenas condiciones, sin alteraciones de ningún tipo. Sus exámenes generales muestran un hemograma normal, así como los electrolitos plasmáticos, las pruebas hepáticas y las pruebas de función renal. El diagnóstico más	a.Meduloblastoma b.Astrocitoma c.Meningitis d.Convulsión idiopática e.Epilepsia primaria

Lia...

probable es:	
13. Un paciente presenta cefalea intensa, pericocular, asociada a miosis y epifora ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:	a.Accidente vascular encefálico hemorrágico b.Accidente vascular isquémico de troncoencéfalo c.Cáncer de pulmón d.Esclerosis múltiple e.Cefalea en racimo
14. Un paciente presenta cefalea opresiva, recurrente, localizada en la zona occipital, que se irradia al cuello. El diagnóstico más probable es:	a.Cefalea tensional b.Jaqueca c.Neuralgia de Arnold d.Síndrome de hipertensión endocraneana e.Cefalea mixta

CUESTIONARIO NEUROLOGIA	2024
1. El síndrome cerebeloso se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:	a.Pérdida de la propiocepción b.Temblor de intención c.Adiadococinesia d.Ataxia e.Hipotonía
2. Un paciente presenta dificultades para ver, caracterizadas por la pérdida de una parte importante del campo visual izquierdo de ambos ojos. De entre las siguientes alternativas, ¿dónde se encuentra localizada la lesión con mayor probabilidad?	a.Quiasma óptico b.Cintilla óptica derecha c.Lóbulo occipital izquierdo d.Nervio óptico derecho e.Nervio óptico izquierdo
3. Una paciente de 30 años presenta un cuadro caracterizado por movimientos involuntarios y rítmicos de la mano derecha, que luego se extienden al brazo derecho. Nunca pierde la conciencia, y está muy preocupada por lo sucedido. El diagnóstico más probable es:	a.Epilepsia tónico-clónica b.Epilepsia mioclónica c.Epilepsia tónica d.Crisis parcial compleja e.Crisis parcial simple
4. La causa más frecuente de hemorragias subaracnoideas espontáneas es:	a.Trastornos de la coagulación b.Infecciones del sistema nerviosos central c.Rotura de aneurismas arteriales encefálicas d.Malformaciones venosas del sistema nervioso central e.Secundaria a hipertensión arterial
5. Un paciente de 30 años, diagnosticado de una vasculitis de Wegener, consulta por parestesias y dificultades para realizar algunos movimientos con los pies y las manos. Al examen físico presenta abolición de los ambos reflejos aquileanos y del reflejo bicipital derecho, asociado a disminución de la sensibilidad de la planta de los pies, mayor al lado derecho. Además, presenta debilidad para flectar el 3° y 4° dedos derechos y marcada dificultad para realizar la eversión de ambos pies. El diagnóstico más probable es:	a.Polineuropatía b.Esclerosis múltiple c.Mononeuritis múltiple d.Esclerosis lateral amiotrófica e.Poliradiculoneuropatía desmielinizante
6. Un paciente de 60 años consulta por desviación de la comisura labial, de inicio súbito, hace algunas horas. Al examen presenta imposibilidad de sonreír y arrugar el mentón con el lado derecho de la cara, asociado a debilidad de los músculos masticatorios del mismo lado. Puede fruncir el ceño y arrugar la frente, de ambos lados, con normalidad. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome de Guillain Barré b.Cefalea cluster c.Síndrome de Ramsey Hunt d.Parálisis de Bell e.Parálisis facial central
7. Las miopatías, a diferencia de las neuropatías, se caracterizan por:	a.Presentar debilidad de predominio proximal, sin atrofia muscular b.Presentar debilidad de predominio proximal, con atrofia muscular c.Presentar debilidad de predominio distal, sin atrofia muscular d.Presentar debilidad de predominio distal, con atrofia muscular e.Presentar debilidad de predominio distal, con hipoestesia “en guante y calcetín”
8. Un paciente de 69 años presenta un cuadro de dos días de evolución de desorientación e ideas paranoides. Se levantó a las 3 de la mañana y fue encontrado por su esposa en el patio, desorientado y diciendo que alguien estaba robando la casa. Ella refiere que hasta ese momento era un paciente autovalente y que se desempeñaba normalmente en sus actividades sociales. El diagnóstico más probable es:	a.Enfermedad de Alzheimer b.Demencia por cuerpos de Lewy c.Hidrocefalia normotensiva d.Accidente vascular encefálico e.Delirium
9. Un niño de 10 años cae de un segundo piso, golpeándose la cabeza contra el suelo y quedando inconsciente por al menos 10 minutos. Después de ese momento despierta algo desorientado y aquejando intenso dolor. Al examen físico presenta equimosis retroauricular. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar radiografía de cráneo y decidir conducta según hallazgos b.Enviar a domicilio con analgésicos y observación cuidadosa, indicando reconsulta, en caso de que aparezcan signos de alarma c.Hospitalizar y solicitar TAC de urgencia sin contraste d.Hospitalizar y realizar punción lumbar e.Hospitalizar y solicitar resonancia magnética nuclear

Lia...

10. Una paciente de 56 años consulta por cefalea recurrente, de carácter opresivo, localizada en la zona temporo-occipital, la que se irradia al cuello. Suele ser mayor en las tardes y cede al dormir. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome de hipertensión endocraneana b.Neuralgia de Arnold c.Cefalea cluster (en racimo) d.Jaqueca e.Cefalea tensional
11. Una paciente de 68 años consulta por temblor de ambas manos, mayor al lado derecho, que se intensifica especialmente al tomar un objeto, como una tasa o un lápiz. Sus movimientos y reflejos, así como la coordinación motora son normales. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar agonistas dopaminérgicos b.Iniciar antagonistas dopaminérgicos c.Iniciar betabloqueantes d.Iniciar betaagonistas e.Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
12. Un paciente de 60 años presenta una hemiparesia braquiocrural derecha, que inició de manera súbita y que duró cerca de 20 minutos, mejorando antes de llegar al servicio de urgencia. Al examen físico presenta normalidad del examen neurológico, aunque está muy preocupada por lo que le pasó. La conducta más adecuada es:	a.Enviar a domicilio, indicando aspirina, sin necesidad de estudio adicional b.Enviar a domicilio, indicando control ambulatorio, para inicio de anticoagulación a permanencia c.Hospitalizar, solicitar una neuroimagen, iniciar medidas de neuroprotección y realizar estudio de fuente embólica d.Hospitalizar, solicitar una neuroimagen, iniciar medidas de neuroprotección y realizar trombolisis intravenosa e.Hospitalizar, solicitar una neuroimagen y observar por 12 horas
13. Un paciente presenta estrabismo, asociado a ptosis y midriasis izquierdas. El diagnóstico más probable es:	a.Afectación del tercer nervio craneal b.Afectación del sexto nervio craneal c.Síndrome de Claude Bernard Horner d.Miastenia gravis e.Afectación del fascículo longitudinal medial
14. Un paciente de 60 años consulta por un cuadro de 3 días de evolución, de debilidad y dificultad para caminar, que ha ido en claro aumento. Al examen se aprecia paresia de las extremidades superiores e inferiores, asociado a abolición de los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:	a.Miastenia gravis b.Síndrome de Guillain Barré c.Polineuropatía d.Esclerosis múltiple e.Esclerosis lateral amiotrófica
15. Un paciente de 60 años presenta vértigo de inicio súbito, muy intenso, que inició hace cerca de 3 horas. Al examen físico presenta lateropulsiones a derecha y nistagmo horizontal, con fase rápida a izquierda. Ha vomitado en varias oportunidades y no se atreve a caminar, porque se cae hacia el lado derecho. El diagnóstico más probable es:	a.Accidente vascular de troncoencéfalo b.Accidente vascular de cerebelo c.Accidente vascular de arteria cerebral anterior d.Esclerosis múltiple e.Neuronitis vestibular
16. Un paciente de 68 años presenta imposibilidad de evocar palabras de inicio súbito, hace 30 minutos, asociado a imposibilidad de realizar movimientos con la extremidad superior derecha. Al examen físico se constata una hemiparesia derecha de predominio braquial, asociada a una afasia de expresión. Se solicita un TAC de cerebro sin contraste, que resulta normal. La conducta más adecuada es:	a.Enviar a domicilio con reposo y control ambulatorio b.Iniciar medidas de neuroprotección y protocolo de trombólisis endovenosa c.Iniciar medidas de neuroprotección y mantener en observación por 24 horas d.Solicitar TAC de cerebro con contraste e.Iniciar de inmediato anticoagulación con heparina, iniciar medidas de neuroprotección y mantener una conducta expectante
17. ¿Cuál de las siguientes alteraciones haría MENOS probable el diagnóstico de una neuralgia primaria del trigémino?	a.Ubicación del dolor en la zona malar y frontal de una hemicara b.El dolor se gatilla al tocar algunas zonas de la cara c.Presencia de alodinia d.La movilidad de la cara es normal e.Presencia de hipoestesia/anestesia de una hemicara
18. Una paciente de 48 años acude al servicio de urgencia por cefalea. Refiere que con cierta frecuencia presenta cefalea, pero que en esta oportunidad es más intensa que lo habitual y que no ha cedido con ibuprofeno y paracetamol. El dolor es de carácter pulsátil, ubicado en la zona frontal y retroocular, mayor al lado izquierdo. Aumenta con la luz y con los ruidos fuertes. Al examen físico no presenta focalidad neurológica y	a.Cefalea cluster b.Hemorragia subaracnoidea c.Migraña d.Cefalea tensional e.Accidente vascular hemorrágico

sus signos vitales son normales. El diagnóstico más probable es:	
19. ¿Qué tratamiento antibiótico es más adecuado para un paciente de 30 años, con una meningitis bacteriana aguda?	a.Ceftriaxona + vancomicina b.Ampicilina + vancomicina c.Ceftriaxona + clindamicina d.Cefepime + metronidazol e.Imipenem
20. Una paciente de 70 años presenta fallas reiteradas de la memoria, en especial de la memoria reciente. No ha presentado alucinaciones, pero últimamente ya no puede utilizar dinero ni tampoco cocinar, ya que comete muchos errores. Al examen físico no tiene focalidad neurológica, está atenta y vigil y presenta una actitud cooperadora, sin embargo, no es capaz de ubicar correctamente los números dentro de un círculo, de modo que asemejen a un reloj. El diagnóstico más probable es:	a.Enfermedad de Alzheimer b.Demencia por cuerpos de Lewy c.Demencia frontotemporal d.Hidrocefalia normotensiva e.Delirium